

Soal Jeopardy

100 Poin

1. Candida albicans merupakan penyebab dari kondisi apa pada rongga mulut?

Jawaban: Oral candidiasis.

Penjelasan: Candida albicans merupakan jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada rongga mulut, salah satunya oral candidiasis. Kondisi ini dapat terjadi ketika keseimbangan mikroorganisme normal atau pertahanan tubuh mengalami gangguan.

2. Apa bentuk diet yang diberikan pada gastric ulcer?

Jawaban: Diet cair atau blenderized.

Penjelasan: Diet cair atau blenderized dapat diberikan untuk memudahkan toleransi makanan dan mengurangi beban mekanis pada lambung pada kondisi gastric ulcer.

3. Apa fungsi kolon dalam penyerapan cairan?

Jawaban: Menyerap air dan elektrolit.

Penjelasan: Kolon berperan dalam menyerap kembali air dan elektrolit dari isi usus sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan membentuk konsistensi feses.

4. Apa fungsi bikarbonat dalam cairan pankreas?

Jawaban: Menetralkan kimus yang asam.

Penjelasan: Bikarbonat dalam cairan pankreas membantu menetralkan kimus yang berasal dari lambung dan bersifat asam ketika memasuki duodenum. Kondisi yang lebih netral atau basa diperlukan agar enzim pankreas dapat bekerja dengan optimal.

5. Apa fungsi empedu dalam pencernaan lemak?

Jawaban: Mengemulsikan lemak.

Penjelasan: Garam empedu membantu memecah globula lemak menjadi tetesan yang lebih kecil sehingga meningkatkan luas permukaan lemak dan memudahkan proses pencernaan serta absorpsi lipid.

200 Poin

1. Sebutkan tiga bentuk diet yang dapat diberikan pada pasien oral candidiasis.

Jawaban: Diet cair, blenderized, dan lunak.

Penjelasan: Bentuk makanan tersebut dapat membantu memudahkan konsumsi pada pasien dengan gangguan atau rasa tidak nyaman pada rongga mulut. Tekstur yang lebih lunak juga membantu mempertahankan asupan energi dan zat gizi.

2. Berapa lama sebelum tidur pasien dengan peptic ulcer sebaiknya tidak makan?

Jawaban: Setidaknya 2 jam.

Penjelasan: Memberikan jeda makan sebelum tidur dapat membantu mengurangi kemungkinan lambung masih dalam keadaan penuh ketika pasien berbaring dan dapat membantu mengurangi keluhan gastrointestinal.

3. Berapa jumlah serat yang direkomendasikan per hari?

Jawaban: 25 gram per hari.

Penjelasan: Asupan serat sekitar 25 gram per hari dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Peningkatan serat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disertai asupan cairan yang cukup.

4. Hormon apa yang disekresikan sebagai respons terhadap kimus asam yang belum dinetralkan?

Jawaban: Sekretin.

Penjelasan: Kimus yang bersifat asam di duodenum merangsang sel S untuk menghasilkan sekretin. Sekretin kemudian merangsang sekresi bikarbonat sehingga membantu menetralkan keasaman kimus.

5. Hormon apa yang merangsang kontraksi kantung empedu?

Jawaban: CCK (Kolesistokinin).

Penjelasan: CCK dilepaskan terutama sebagai respons terhadap lemak dan asam amino di usus. Hormon ini merangsang kontraksi kantung empedu dan relaksasi sfingter Oddi sehingga empedu dapat dialirkan ke duodenum.

300 Poin

1. Berapa lama pasien GERD sebaiknya tidak makan sebelum tidur?

Jawaban: 3 jam.

Penjelasan: Memberikan jeda sekitar 3 jam antara makan terakhir dan waktu tidur dapat mengurangi kemungkinan terjadinya refluks ketika pasien berada dalam posisi berbaring.

2. Apa yang harus dilakukan terhadap makanan yang secara langsung mengiritasi mukosa lambung pada pasien peptic ulcer?

Jawaban: Mengidentifikasi dan menghindarinya.

Penjelasan: Makanan yang terbukti menimbulkan iritasi atau ketidaknyamanan sebaiknya diidentifikasi dan dihindari. Pembatasan makanan tidak perlu dilakukan secara berlebihan apabila makanan tersebut tidak menimbulkan keluhan.

3. Sebutkan dua contoh bahan makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan asupan serat.

Jawaban: Biji-bijian utuh dan sayuran.

Penjelasan: Biji-bijian utuh dan sayuran merupakan sumber serat yang baik. Konsumsi berbagai sumber serat dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian dan mendukung fungsi saluran gastrointestinal.

4. Sebutkan tiga penyebab pankreatitis!

Jawaban: Alkohol berlebihan, hipertrigliseridemia, dan sumbatan duktus pankreas.

Penjelasan: Pankreatitis dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk konsumsi alkohol berlebihan, kadar trigliserida yang tinggi, serta obstruksi duktus pankreas, misalnya akibat batu empedu.

5. Apa yang terjadi pada kantung empedu ketika CCK dilepaskan?

Jawaban: Kantung empedu berkontraksi.

Penjelasan: CCK menyebabkan kontraksi kantung empedu sehingga empedu dikeluarkan menuju duodenum. CCK juga menyebabkan relaksasi sfingter Oddi sehingga mempermudah aliran empedu.

400 Poin

1. Mengapa makanan tinggi lemak perlu dihindari pada pasien GERD?

Jawaban: Karena makanan tinggi lemak menurunkan tekanan sfingter esofagus bawah serta menyebabkan pengosongan lambung terhambat.

Penjelasan: Makanan tinggi lemak dapat menurunkan tekanan sfingter esofagus bawah dan memperlambat pengosongan lambung. Kondisi tersebut dapat meningkatkan distensi lambung dan mempermudah terjadinya refluks isi lambung ke esofagus.

2. Mengapa status gizi yang baik perlu dipertahankan pada pasien peptic ulcer?

Jawaban: Karena membantu mempertahankan kondisi tubuh dan mendukung proses pemulihan.

Penjelasan: Status gizi yang baik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi selama proses penyakit dan pemulihan. Pengaturan makan pada peptic ulcer sebaiknya tetap mempertahankan kecukupan zat gizi dan tidak melakukan pembatasan makanan yang tidak diperlukan.

3. Apa yang dapat terjadi jika seseorang meningkatkan asupan serat terlalu cepat?

Jawaban: Flatulensi, borborygmus, kram, dan diare.

Penjelasan: Peningkatan serat secara mendadak dapat menyebabkan perubahan aktivitas saluran cerna dan meningkatkan fermentasi di usus sehingga dapat menimbulkan flatulensi, borborygmus, kram, dan diare.

4. Apa yang dilakukan terhadap pemberian makanan secara oral pada serangan pankreatitis akut berat?

Jawaban: Pemberian makanan oral dihentikan.

Penjelasan: Pada serangan pankreatitis akut berat, pemberian makanan oral dapat dihentikan pada fase awal dan pasien diberikan hidrasi intravena. Setelah kondisi memungkinkan, asupan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai toleransi.

5. Sebutkan empat prinsip pengaturan diet pada cholecystitis kronis.

Jawaban: Diet rendah lemak, penurunan berat badan, pembatasan makanan pembentuk gas, dan suplementasi vitamin A, D, E, dan K.

Penjelasan: Pengaturan diet pada cholecystitis kronis bertujuan mengurangi rangsangan terhadap kantung empedu dan mempertahankan kecukupan zat gizi. Diet rendah lemak dapat mengurangi rangsangan kontraksi kantung empedu, sedangkan pembatasan makanan pembentuk gas dapat membantu mengurangi keluhan gastrointestinal.

500 Poin

1. Seorang pasien GERD sering makan malam kemudian langsung berbaring. Ia juga memiliki berat badan berlebih dan sering mengonsumsi makanan tinggi lemak serta kopi. Sebutkan empat perubahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut.

Jawaban: Menurunkan berat badan, tidak makan 3 jam sebelum tidur, menghindari makanan tinggi lemak, dan mengurangi kopi.

Penjelasan: Penurunan berat badan pada pasien dengan berat badan berlebih dapat membantu mengurangi faktor yang berhubungan dengan refluks. Jeda sekitar 3 jam antara makan dan tidur mengurangi risiko refluks saat berbaring. Pembatasan makanan tinggi lemak dan kopi dapat dilakukan apabila keduanya memicu atau memperberat gejala.

2. Seorang pasien dengan peptic ulcer mengatakan bahwa setiap kali mengonsumsi makanan tertentu, ia mengalami ketidaknyamanan. Ia juga memiliki kebiasaan makan mendekati waktu tidur. Berdasarkan kondisi tersebut, apa dua hal utama yang perlu dilakukan dalam pengaturan makannya?

Jawaban: Menghindari makanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak makan setidaknya 2 jam sebelum tidur.

Penjelasan: Makanan yang secara konsisten menimbulkan ketidaknyamanan sebaiknya diidentifikasi dan dihindari. Selain itu, memberikan jeda setidaknya 2 jam sebelum tidur dapat membantu mengurangi keluhan gastrointestinal ketika pasien berbaring.

3. Seorang pasien mengalami konstipasi. Ia memiliki pola makan rendah serat dan jarang melakukan aktivitas fisik. Dokter menyarankan peningkatan serat. Pasien kemudian meningkatkan serat secara drastis tetapi asupan cairannya tetap rendah. Apa masalah yang dapat terjadi dan apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian serat?

Jawaban: Dapat terjadi obstruksi lambung atau fecal impaction; peningkatan serat perlu dilakukan secara bertahap dan disertai cairan yang cukup.

Penjelasan: Peningkatan serat yang terlalu cepat dengan asupan cairan yang tidak memadai dapat menyebabkan feses menjadi lebih sulit dikeluarkan dan pada kondisi

tertentu dapat berkontribusi terhadap fecal impaction atau obstruksi. Oleh karena itu, serat perlu ditingkatkan secara bertahap dan disertai cairan yang cukup.

4. Seorang pasien mengalami pankreatitis akut berat. Pada awal perawatan, pasien tidak diberikan makanan melalui oral dan mendapat hidrasi intravena. Setelah 24 jam, pasien mulai dapat menerima asupan. Apa yang dapat diberikan berikutnya? Jika pankreatitis berat berlangsung lama, bentuk dukungan nutrisi apa yang dapat digunakan?

Jawaban: Cairan jernih sesuai toleransi setelah 24–48 jam; pada pankreatitis berat yang berlangsung lama dapat diberikan TPN.

Penjelasan: Setelah fase awal dan kondisi pasien memungkinkan, pemberian cairan jernih dapat dimulai secara bertahap sesuai toleransi. Apabila kebutuhan nutrisi tidak dapat dipenuhi melalui saluran gastrointestinal dalam kondisi pankreatitis berat yang berkepanjangan, dukungan nutrisi parenteral seperti TPN dapat digunakan.

5. Seorang pasien dengan penyakit kantung empedu mengonsumsi makanan tinggi lemak. Setelah lemak masuk ke usus, terjadi pelepasan hormon yang menyebabkan kantung empedu berkontraksi. Dokter kemudian menganjurkan diet rendah lemak. Apa hormon tersebut dan mengapa pembatasan lemak digunakan pada kondisi tersebut?

Jawaban: Hormon tersebut adalah CCK; pembatasan lemak digunakan untuk mengurangi kontraksi kantung empedu.

Penjelasan: Lemak yang masuk ke duodenum merangsang pelepasan CCK. CCK menyebabkan kontraksi kantung empedu dan membantu pengeluaran empedu. Pembatasan lemak dapat mengurangi rangsangan terhadap kontraksi tersebut sehingga membantu mengurangi keluhan.

Soal Gimkit

A. GERD

1. Seorang pasien GERD mengeluhkan heartburn terutama setelah makan dalam jumlah banyak. Modifikasi pola makan yang paling sesuai adalah...

- A. Meningkatkan frekuensi makan dalam porsi besar
- B. Mengurangi ukuran porsi makan dan menghindari makan dalam jumlah besar
- C. Mengganti makanan padat dengan makanan tinggi lemak
- D. Meningkatkan konsumsi kopi setelah makan
- E. Menambah makanan pedas untuk merangsang pencernaan

Jawaban: B

Penjelasan: Porsi makan yang besar dapat meningkatkan distensi lambung dan mempermudah terjadinya refluks. Mengurangi ukuran porsi dapat membantu mengurangi distensi lambung dan keluhan heartburn.

2. Pasien GERD sering mengalami gejala ketika langsung berbaring setelah makan malam. Edukasi yang paling tepat adalah...

- A. Berbaring segera setelah makan agar lambung beristirahat

- B. Mengonsumsi makanan tinggi lemak sebelum tidur
- C. Menghindari berbaring setelah makan dan memberi jeda sebelum tidur
- D. Mengonsumsi kopi untuk mempercepat pengosongan lambung
- E. Meningkatkan porsi makan malam

Jawaban: C

Penjelasan: Berbaring segera setelah makan dapat mempermudah isi lambung mengalami refluks ke esofagus. Memberikan jeda sebelum tidur membantu mengurangi kemungkinan terjadinya refluks.

3. Seorang pasien GERD ingin mengetahui jenis minuman yang sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan keasaman sekresi lambung. Pilihan yang paling tepat adalah...

- A. Air putih
- B. Cairan elektrolit
- C. Kopi dan minuman berkafein
- D. Kuah bening
- E. Air mineral

Jawaban: C

Penjelasan: Kopi dan minuman berkafein dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan pada sebagian pasien dapat memperberat gejala. Konsumsinya dapat dibatasi terutama apabila terbukti memicu keluhan.

4. Seorang pasien GERD mengatakan gejalanya sering muncul setelah mengonsumsi makanan dalam jumlah besar dan tinggi lemak. Intervensi gizi yang paling sesuai adalah...

- A. Meningkatkan konsumsi lemak untuk memperlambat pengosongan lambung
- B. Mengurangi makanan tinggi lemak dan menghindari porsi besar
- C. Menghilangkan seluruh sumber karbohidrat
- D. Meningkatkan konsumsi makanan pedas
- E. Mengurangi seluruh asupan cairan

Jawaban: B

Penjelasan: Makanan tinggi lemak dapat memperlambat pengosongan lambung, sedangkan porsi besar meningkatkan distensi lambung. Kedua kondisi tersebut dapat memperberat refluks sehingga pembatasan lemak dan pengaturan ukuran porsi dapat membantu mengurangi gejala.

B. Gastritis dan Ulkus Peptikum

5. Pasien gastritis mengalami nyeri epigastrium setelah mengonsumsi makanan yang sangat pedas. Edukasi gizi yang paling sesuai adalah...

- A. Meningkatkan konsumsi cabai agar toleransi lambung meningkat
- B. Mengurangi konsumsi rempah terutama ketika mukosa sedang mengalami inflamasi
- C. Mengganti makanan pedas dengan makanan tinggi lemak
- D. Meningkatkan konsumsi kopi setelah makan
- E. Menghentikan seluruh konsumsi protein

Jawaban: B

Penjelasan: Apabila makanan pedas terbukti memicu nyeri atau ketidaknyamanan, konsumsinya sebaiknya dikurangi, terutama ketika mukosa lambung sedang mengalami inflamasi.

6. Pasien gastritis terbiasa mengonsumsi kopi beberapa kali sehari. Modifikasi diet yang paling sesuai adalah...

- A. Mengurangi konsumsi kopi dan kafein
- B. Mengonsumsi kopi hanya saat perut kosong
- C. Mengganti kopi dengan minuman berkafein lain
- D. Meningkatkan jumlah kopi tetapi mengurangi makanan
- E. Mengonsumsi kopi bersama makanan tinggi lemak

Jawaban: A

Penjelasan: Kopi dan kafein dapat memperberat keluhan pada sebagian pasien dengan gastritis. Mengurangi konsumsi kopi dapat membantu menghindari pemicu gejala.

7. Dalam penatalaksanaan gizi gastritis/ulkus peptikum, kelompok makanan/minuman yang perlu dikurangi terutama saat inflamasi adalah...

- A. Air putih, nasi, dan buah
- B. Alkohol, rempah tertentu, kopi, dan kafein
- C. Protein, vitamin, dan mineral
- D. Serat larut dan cairan
- E. Karbohidrat kompleks dan protein

Jawaban: B

Penjelasan: Alkohol, kopi, kafein, dan rempah tertentu dapat menjadi pemicu iritasi atau memperberat keluhan gastrointestinal pada sebagian pasien. Konsumsinya dapat dikurangi terutama ketika menimbulkan gejala.

8. Seorang pasien gastritis ingin memperbaiki pola makannya. Asupan asam lemak tertentu yang dapat memberikan efek protektif adalah...

- A. Asam lemak trans
- B. Omega-3 dan omega-6
- C. Asam lemak jenuh saja
- D. Kolesterol
- E. Lemak terhidrogenasi

Jawaban: B

Penjelasan: Asam lemak omega-3 dan omega-6 merupakan asam lemak tak jenuh yang berperan dalam berbagai proses fisiologis dan dapat mendukung respons tubuh terhadap proses inflamasi.

C. Gastroenteritis

9. Pasien gastroenteritis mengalami diare berulang dan kehilangan cairan. Prioritas intervensi gizinya adalah...

- A. Meningkatkan asupan serat
- B. Mengganti cairan dan elektrolit yang hilang

- C. Mengurangi seluruh asupan cairan
- D. Meningkatkan konsumsi lemak
- E. Memberikan makanan padat dalam jumlah besar

Jawaban: B

Penjelasan: Diare menyebabkan kehilangan air dan elektrolit sehingga prioritas utama adalah mengganti kehilangan tersebut untuk mencegah dehidrasi dan gangguan elektrolit.

10. Pasien gastroenteritis masih mampu minum tetapi mengalami kehilangan cairan melalui diare. Pilihan yang paling sesuai pada tahap awal adalah...

- A. Minuman tinggi gula
- B. Cairan bening yang mengandung elektrolit
- C. Minuman berkafein
- D. Minuman berkarbonasi
- E. Makanan tinggi serat kasar

Jawaban: B

Penjelasan: Cairan yang mengandung elektrolit membantu menggantikan air dan elektrolit yang hilang akibat diare. Rehidrasi oral menjadi pilihan apabila pasien masih mampu minum.

11. Setelah pemberian cairan bening yang mengandung elektrolit, pasien mulai mampu mentoleransi asupan. Perkembangan diet yang paling sesuai adalah...

- A. Langsung makanan tinggi lemak
- B. Kuah bening dan gelatin
- C. Makanan pedas dan berminyak
- D. Makanan tinggi serat kasar
- E. Minuman berkafein

Jawaban: B

Penjelasan: Setelah pasien mampu mentoleransi cairan, diet dapat dikembangkan secara bertahap. Kuah bening dan gelatin merupakan contoh makanan yang relatif mudah ditoleransi sebelum beralih ke makanan yang lebih padat.

12. Mengapa minuman berkarbonasi, berkafein, dan tinggi gula sebaiknya dihindari pada gastroenteritis?

- A. Seluruhnya meningkatkan absorpsi air di usus
- B. Dapat meningkatkan diare
- C. Menghentikan motilitas usus
- D. Menurunkan kebutuhan elektrolit
- E. Mempercepat perkembangan diet

Jawaban: B

Penjelasan: Minuman tinggi gula, berkafein, atau berkarbonasi dapat memperburuk gejala gastrointestinal pada sebagian pasien dan berpotensi memperberat diare.

13. Seorang pasien gastroenteritis mulai dapat makan kembali setelah fase cair. Prinsip perkembangan diet yang paling tepat adalah...

- A. Diet dikembangkan berdasarkan toleransi pasien
- B. Diet harus langsung kembali seperti sebelum sakit
- C. Diet harus tetap cair sampai seluruh gejala hilang
- D. Diet harus tinggi lemak untuk mengganti energi
- E. Diet harus bebas cairan

Jawaban: A

Penjelasan: Perkembangan diet dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pasien dalam mentoleransi makanan. Jika toleransi baik, bentuk dan jumlah makanan dapat ditingkatkan secara progresif.

14. Kelompok pasien yang dapat membutuhkan terapi rehidrasi oral secara khusus adalah...

- A. Dewasa sehat tanpa kehilangan cairan
- B. Bayi, anak-anak, dan lansia
- C. Pasien dengan kelebihan cairan
- D. Pasien dengan konstipasi
- E. Pasien tanpa gejala gastrointestinal

Jawaban: B

Penjelasan: Bayi, anak-anak, dan lansia lebih rentan mengalami gangguan keseimbangan cairan sehingga kehilangan cairan akibat diare perlu mendapat perhatian khusus.

15. Pasien gastroenteritis mengalami muntah dan diare yang menetap serta tidak mampu memenuhi kebutuhan cairan secara oral. Intervensi yang sesuai adalah...

- A. Pembatasan cairan
- B. Cairan intravena
- C. Diet tinggi serat
- D. Diet tinggi lemak
- E. Penghentian seluruh cairan

Jawaban: B

Penjelasan: Apabila pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan cairan melalui oral karena muntah atau kehilangan cairan yang berat, cairan intravena dapat diberikan untuk mempertahankan volume cairan dan keseimbangan elektrolit.

D. Kolitis

16. Pada fase awal episode akut kolitis, bentuk diet yang sesuai adalah...

- A. Diet tinggi serat
- B. Diet cair
- C. Diet tinggi lemak
- D. Diet bebas cairan
- E. Diet makanan mentah

Jawaban: B

Penjelasan: Pada fase akut kolitis, diet cair dapat membantu mengurangi beban saluran gastrointestinal dan lebih mudah ditoleransi ketika gejala masih berat.

17. Setelah kondisi pasien kolitis membaik, perkembangan diet yang sesuai adalah...

- A. Cair → tinggi lemak
- B. Cair → lunak
- C. Lunak → bebas cairan
- D. Cair → tinggi serat langsung
- E. Cair → makanan pedas

Jawaban: B

Penjelasan: Ketika kondisi pasien membaik dan toleransi meningkat, diet dapat dikembangkan secara bertahap dari makanan cair menuju makanan lunak sebelum kembali ke pola makan yang lebih normal.

18. Diet lunak pada pasien kolitis dapat diberikan setelah sekitar...

- A. 6–12 jam
- B. 1 hari
- C. 2–3 hari
- D. 1–2 minggu
- E. 1 bulan

Jawaban: C

Penjelasan: Diet lunak dapat mulai diberikan sekitar 2–3 hari setelah fase awal apabila kondisi pasien membaik dan saluran gastrointestinal mampu mentoleransi peningkatan bentuk makanan.

19. Setelah episode akut kolitis, diet rendah serat diberikan selama beberapa minggu dan dapat disertai...

- A. Laksatif rutin
- B. Pelunak feses
- C. Pembatasan cairan
- D. Diet tinggi lemak
- E. Penghentian seluruh makanan

Jawaban: B

Penjelasan: Pelunak feses membantu menghasilkan feses yang lebih lunak sehingga proses defekasi lebih mudah dan dapat mengurangi ketegangan saat buang air besar.

20. Setelah kolitis mengalami penyembuhan, perubahan diet yang paling sesuai adalah...

- A. Mempertahankan diet rendah serat tanpa batas waktu
- B. Meningkatkan serat dan asupan cairan
- C. Mengurangi cairan untuk mencegah diare
- D. Meningkatkan lemak untuk menambah energi
- E. Mempertahankan diet cair

Jawaban: B

Penjelasan: Setelah kondisi akut membaik, peningkatan serat dan cairan membantu mendukung fungsi saluran cerna dan mencegah konstipasi.

21. Mengapa peningkatan serat dan cairan dianjurkan setelah kolitis sembuh?

- A. Untuk meningkatkan sekresi asam lambung
- B. Untuk membantu mencegah konstipasi
- C. Untuk mempercepat terjadinya diare
- D. Untuk menurunkan kebutuhan energi
- E. Untuk meningkatkan absorpsi lemak

Jawaban: B

Penjelasan: Serat membantu meningkatkan massa dan memperbaiki konsistensi feses, sedangkan cairan membantu menjaga feses tetap lunak. Kombinasi keduanya membantu mencegah konstipasi.

22. Pada fase setelah penyembuhan kolitis, intervensi berikut yang justru perlu dihindari adalah...

- A. Peningkatan cairan
- B. Peningkatan serat
- C. Laksatif dan enema
- D. Diet bertahap
- E. Pelunak feses

Jawaban: C

Penjelasan: Penggunaan laksatif dan enema secara rutin tidak diperlukan apabila fungsi defekasi sudah dapat dipertahankan melalui pengaturan diet, cairan, dan kebiasaan buang air besar.

E. Hemoroid

23. Pasien hemoroid mengalami konstipasi dan sering mengejan saat defekasi. Intervensi gizi yang paling tepat adalah...

- A. Diet rendah serat dan rendah cairan
- B. Diet tinggi serat dan peningkatan cairan
- C. Diet tinggi lemak
- D. Pembatasan cairan
- E. Menghindari seluruh makanan padat

Jawaban: B

Penjelasan: Peningkatan serat dan cairan membantu menghasilkan feses yang lebih lunak dan mudah dikeluarkan sehingga dapat mengurangi konstipasi dan kebiasaan mengejan.

24. Tujuan utama peningkatan serat pada pasien hemoroid dengan konstipasi adalah...

- A. Mengurangi kebutuhan cairan
- B. Membantu mengatasi konstipasi
- C. Menghambat motilitas usus
- D. Meningkatkan konsistensi feses
- E. Meningkatkan mengejan

Jawaban: B

Penjelasan: Serat membantu meningkatkan volume feses dan memperbaiki konsistensinya sehingga defekasi menjadi lebih mudah. Hal ini membantu mengatasi konstipasi dan mengurangi kebutuhan untuk mengejan.

25. Pasien hemoroid diberikan stool softener. Tujuan intervensi tersebut dalam konteks gizi adalah...

- A. Meningkatkan kebutuhan energi
- B. Membantu mencegah mengejan saat defekasi
- C. Mengurangi asupan serat
- D. Meningkatkan retensi cairan
- E. Menghambat defekasi

Jawaban: B

Penjelasan: Stool softener membantu membuat feses lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan dan mengurangi kebutuhan mengejan saat defekasi.

26. Seorang pasien hemoroid sudah meningkatkan serat dan cairan, tetapi masih mengeluhkan ketidaknyamanan. Tindakan pendukung yang dapat dilakukan adalah...

- A. Sitz bath
- B. Pembatasan cairan
- C. Diet bebas serat
- D. Diet tinggi lemak
- E. Puasa total

Jawaban: A

Penjelasan: Sitz bath menggunakan air hangat untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada daerah perianal dan dapat menjadi terapi pendukung pada pasien dengan hemoroid.

F. Pankreatitis dan Kolesistitis

27. Pada pankreatitis akut, NPO diberikan terutama untuk...

- A. Meningkatkan absorpsi lemak
- B. Mengurangi sekresi lambung
- C. Meningkatkan motilitas kolon
- D. Meningkatkan asupan protein
- E. Mempercepat pemberian makanan padat

Jawaban: B

Penjelasan: NPO pada fase awal pankreatitis akut bertujuan mengurangi stimulasi gastrointestinal dan sekresi pencernaan yang dapat merangsang aktivitas pankreas.

28. Pasien pankreatitis akut menjalani NPO. Dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan cairan adalah...

- A. Pembatasan elektrolit
- B. Cairan dan elektrolit intravena
- C. Minuman tinggi gula
- D. Diet tinggi serat

E. Diet tinggi lemak

Jawaban: B

Penjelasan: Karena pasien tidak mendapatkan cairan dan elektrolit melalui asupan oral selama NPO, kebutuhan cairan dan elektrolit perlu dipenuhi melalui pemberian intravena sesuai kondisi pasien.

29. Bila kebutuhan dukungan nutrisi tidak dapat dipenuhi melalui saluran gastrointestinal, maka salah satu bentuk dukungan nutrisi yang dapat diberikan adalah...

- A. Diet tinggi serat
- B. TPN
- C. Diet tinggi lemak
- D. Minuman berkarbonasi
- E. Diet bebas cairan

Jawaban: B

Penjelasan: TPN atau total parenteral nutrition diberikan melalui jalur intravena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui saluran gastrointestinal.

30. Pasien kolesistitis akut masih mengalami gejala akut. Penatalaksanaan nutrisi awal yang sesuai adalah...

- A. Diet tinggi lemak
- B. NPO disertai cairan dan elektrolit intravena
- C. Diet tinggi serat
- D. Diet bebas lemak tanpa cairan
- E. Makanan padat dalam jumlah besar

Jawaban: B

Penjelasan: Pada fase akut dengan gejala yang masih berat, NPO dapat digunakan untuk mengurangi stimulasi gastrointestinal, sementara kebutuhan cairan dan elektrolit dipenuhi melalui pemberian intravena.

31. Setelah gejala akut kolesistitis mereda, perkembangan diet yang sesuai adalah...

- A. Diet tinggi lemak
- B. Diet rendah lemak
- C. Diet tinggi serat tanpa batasan lemak
- D. Diet bebas cairan
- E. Diet cair saja dalam jangka panjang

Jawaban: B

Penjelasan: Setelah gejala akut mereda, diet dapat dikembangkan dengan memperhatikan toleransi pasien. Diet rendah lemak membantu mengurangi rangsangan kontraksi kantung empedu dan dapat membantu mengurangi keluhan.

32. Seorang pasien kolesistitis bertanya kapan diet rendah lemak mulai dikembangkan. Jawaban yang paling sesuai adalah...

- A. Sebelum gejala akut muncul

- B. Saat pasien masih dalam kondisi NPO
- C. Setelah gejala akut mereda
- D. Hanya setelah satu tahun
- E. Setelah pasien mengalami konstipasi

Jawaban: C

Penjelasan: Diet rendah lemak dikembangkan setelah gejala akut mereda dan pasien mulai mampu menerima makanan. Pemberian makanan dilakukan secara bertahap sesuai toleransi.

G. Penyakit Hati

33. Pasien dengan penyakit hati mengalami penurunan asupan dan gangguan proses metabolisme sehingga berisiko mengalami...

- A. Malnutrisi
- B. Peningkatan cadangan glikogen
- C. Peningkatan fungsi sintesis hati
- D. Peningkatan absorpsi seluruh zat gizi
- E. Peningkatan massa otot secara otomatis

Jawaban: A

Penjelasan: Penyakit hati dapat menyebabkan penurunan asupan serta gangguan metabolisme dan penyimpanan zat gizi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi, termasuk kehilangan massa otot.

34. Pada gagal hati akut, perubahan metabolisme karbohidrat yang dapat berkontribusi terhadap hipoglikemia adalah...

- A. Peningkatan glukoneogenesis
- B. Penurunan glukoneogenesis
- C. Peningkatan cadangan glikogen
- D. Peningkatan clearance laktat
- E. Peningkatan produksi glukosa tanpa batas

Jawaban: B

Penjelasan: Pada gagal hati akut, kemampuan hati melakukan glukoneogenesis dapat menurun. Penurunan produksi glukosa tersebut dapat berkontribusi terhadap terjadinya hipoglikemia.

35. Pada penyakit hati kronis/sirosis, perubahan metabolisme karbohidrat yang perlu diperhatikan dalam aspek gizi adalah...

- A. Peningkatan sensitivitas insulin pada seluruh pasien
- B. Glucose intolerance/insulin resistance
- C. Peningkatan cadangan glikogen
- D. Penurunan gluconeogenesis sebagai satu-satunya perubahan
- E. Peningkatan fungsi hati

Jawaban: B

Penjelasan: Pada penyakit hati kronis atau sirosis dapat terjadi glucose intolerance dan insulin resistance. Kondisi tersebut menyebabkan regulasi metabolisme glukosa terganggu sehingga perlu diperhatikan dalam pengaturan nutrisi.

36. Pada pasien sirosis stabil, BCAA dapat diberikan terutama untuk...

- A. Menghentikan seluruh asupan protein
- B. Membantu mencegah komplikasi
- C. Mengurangi kebutuhan cairan
- D. Meningkatkan konsumsi lemak
- E. Menghambat seluruh metabolisme asam amino

Jawaban: B

Penjelasan: BCAA atau branched-chain amino acids dapat digunakan sebagai bagian dari dukungan nutrisi pada pasien sirosis tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan asam amino dan mendukung kondisi nutrisi pasien.

37. Salah satu manfaat BCAA adalah...

- A. Meningkatkan anoreksia
- B. Mengurangi anoreksia
- C. Meningkatkan kehilangan elektrolit
- D. Menghambat absorpsi protein
- E. Menurunkan kebutuhan energi

Jawaban: B

Penjelasan: Pemberian BCAA pada pasien penyakit hati tertentu dapat membantu meningkatkan asupan dan mengurangi anoreksia sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi.

38. Pada pasien penyakit hati yang tidak toleran terhadap protein minimal, BCAA dapat diberikan pada toleransi protein sekitar...

- A. $<0,25$ g/kgBB
- B. $<0,5$ g/kgBB
- C. ≥ 1 g/kgBB
- D. ≥ 3 g/kgBB
- E. ≥ 5 g/kgBB

Jawaban: C

Penjelasan: BCAA dapat dipertimbangkan pada pasien penyakit hati yang tidak dapat mentoleransi kebutuhan protein minimal, dengan toleransi protein sekitar ≥ 1 g/kgBB sesuai kondisi dan kebutuhan pasien.